

# Behandlung gemeinsam verstehen

*Wer die Logik dahinter kennt — welche Phase, welches Ziel, woran sich etwas zeigt — kann mitdenken und mitsprechen, ohne fachliche Entscheidungen übernehmen zu müssen. Dieses Blatt ersetzt keine fachliche Abklärung, Diagnose oder Behandlung.*

## WORUM ES GEHT

Für Angehörige wirkt Behandlung manchmal unübersichtlich: Medikamente, Psychotherapie, Schlaf, Blutkontrollen, Frühwarnzeichen, Angehörigengespräche und Krisenwege stehen nebeneinander.

Hilfreicher ist eine phasenorientierte Sicht. Nicht jede Massnahme zielt auf dasselbe — und nicht alles ist gleichzeitig dran. Wenn klar ist, welche Phase gerade trägt und welches Ziel sie hat, lässt sich im Behandlungsgespräch mitdenken, statt nur zuzusehen.

## FRAGEN FÜRS NÄCHSTE BEHANDLUNGSGESPRÄCH

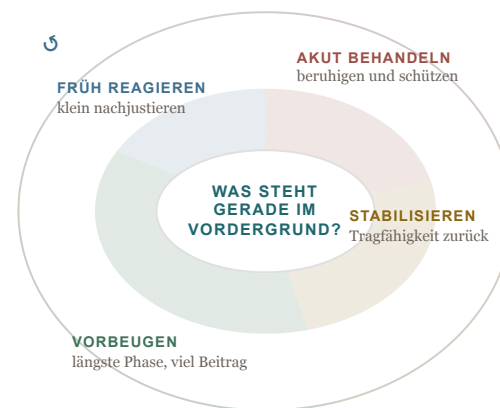
- Welche Phase steht gerade im Vordergrund: Hochphase, Depression, Stabilisierung oder Vorbeugung?
- Was ist das Behandlungsziel dieser Phase: beruhigen, aktivieren, stabilisieren oder vorbeugen?
- Welche Kontrollen sind vereinbart: Blutwerte, Gewicht, Stoffwechsel, Nieren, Schilddrüse oder Spiegel?
- Woran würden wir gemeinsam merken, dass nachjustiert werden sollte?

### ENTLASTENDER KERNSATZ

Behandlung ist kein Entweder-oder. Sie ist ein Zusammenspiel aus fachlicher Therapie, Rhythmus, Beobachtung und Absprachen.

## BEHANDLUNGSKOMPASS · VIER PHASEN, KEIN ENDPUNKT

Die vier Phasen sind kein Weg mit Ziellinie, sondern ein Kreis. Vorbeugen ist nie «erledigt», und früh reagieren führt bei Bedarf zurück in die akute Behandlung.



### AKUT BEHADELN

Sicherheit, Schlaf, Risiko und deutliche Symptomverdichtung brauchen fachliche Einschätzung.

### STABILISIEREN

Wirksame Schritte werden weitergeführt; Nebenwirkungen, Schlaf und Alltag werden mitbeobachtet.

### VORBEUGEN

Rückfallprophylaxe, Psychoedukation, Psychotherapie, Rhythmus und Angehörigeneinbezug greifen zusammen.

### FRÜH REAGIEREN

Warnzeichen werden nicht dramatisiert, aber rechtzeitig und konkret besprochen.

## NICHT NUR MEDIKATION

- **Phasengerecht:** Was in Manie hilft, passt nicht zwingend in Depression oder Vorbeugung.
- **Antidepressiva:** Bei Bipolarität spielen sie eine vorsichtiger Rolle.
- **Anpassungen:** Veränderungen brauchen Zeit und Begleitung, kein abruptes Stoppen.
- **Schlaf und Rhythmus:** Angehörige können Verlauf und frühe Veränderungen sichtbar halten.

## IM GESPRÄCH MITDENKEN

Phase, Ziel, Kontrollen und Nachjustieren klären — ohne fachliche Entscheidungen zu übernehmen.

## KONKRETER NÄCHSTER SCHRITT

Bestimmen Sie heute nur eines: Welche Phase steht im Vordergrund? Notieren Sie eine sichtbare Veränderung mit Datum.